



国家基层高血压防治管理指南

基层高血压管理

国家心血管病中心
国家基本公共卫生服务项目 基层高血压管理办公室

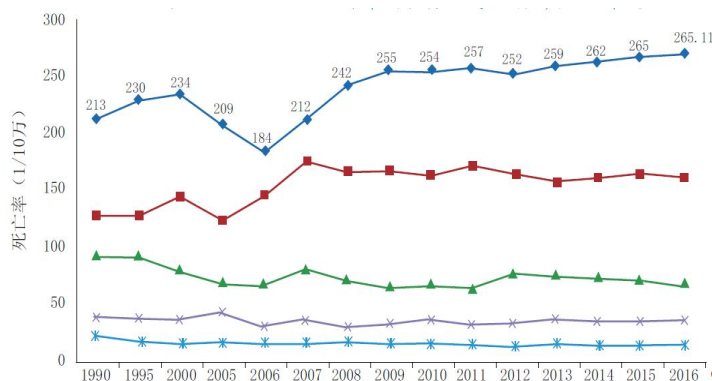


报告提纲

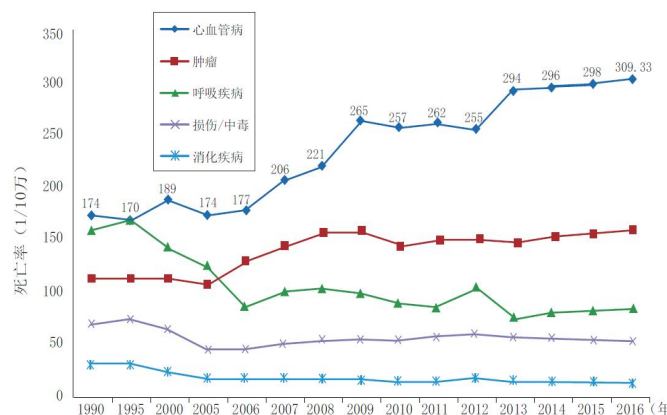
- 背景
- 指南介绍
- 指南推广

管好高血压，预防心血管病是国家重大战略需求

- 全国心血管病患者 **3.3亿**，仍在持续上升
- 每年约 **430万** 人死于心血管病，占总死亡 **42%**，拐点尚未到来
- 控制血压是预防心血管疾病的最重要措施



近20年中国心血管病死亡率（城市）



近20年中国心血管病死亡率（农村）

降压治疗的好处

尽管高血压危害极大，但可预防、可控制

收缩压每降低10mmHg，或舒张压每降低5mmHg：

- 死亡风险降低10%-15%
- 冠心病风险降低20%
- 脑卒中风险降低35%
- 心力衰竭风险降低40%

降压是降低心脑血管病疾病最有效的手段之一！

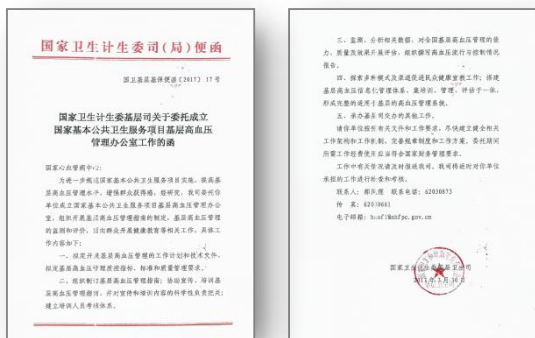
我国高血压管理现况亟待改善

	中国慢病前瞻研究 (CKB, 2004-2009)	营养与慢病调查 (2012)	十二五 高血压调查 (2012-2015)	高危筛查项目 (China PEACE MPP, 2014-2017)
调查对象	35-74岁 50万	18岁以上 10万	18岁以上 45万	35-75岁 170万
患病率	32.5%	25.2%	23.2%	44.7% (检出率)
知晓率	30.5%	46.5%	46.9%	44.7%
治疗率	46.4%	41.1%	40.7%	30.1%
控制率	4.2%	13.8%	15.3%	7.2%

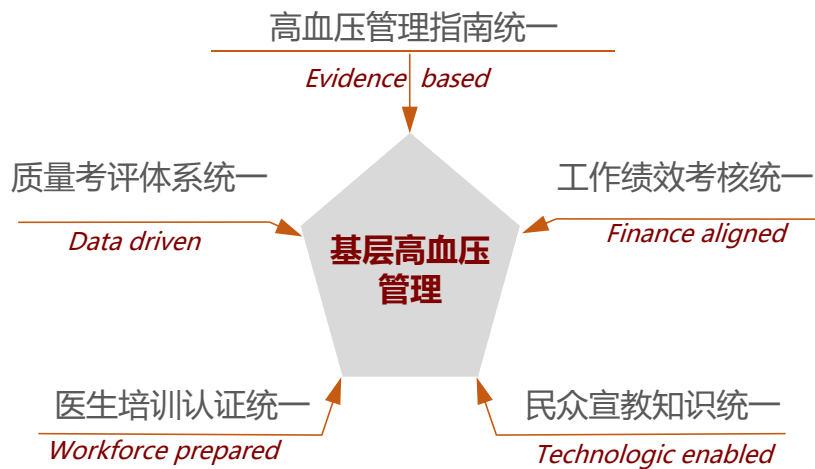
国家基层高血压管理办公室

工作目标

- 逐步实现基层医疗机构和医院高血压管理水平同质化
- 逐步提高基层医疗机构高血压首诊率
- 逐步提升基层医疗机构高血压控制率



国家卫健委委托函



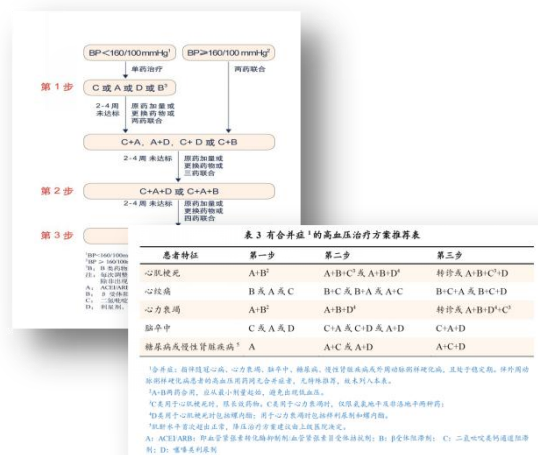
《国家基层高血压防治管理指南》2017



国家卫计委新闻发布会



体现政府意志



简单实用，基层可掌握

指导国家基本公共卫生服务项目的高血压管理

更新《指南》 2020版，发布《手册》 2020版



- 基层高血压管理要求
 - 人员
 - 设备
 - 药品
- 高血压诊断
- 高血压治疗
- **高血压与中医药**
- 转诊与长期随访



指导国家基本公共卫生服务项目的高血压管理

国家基层高血压防治管理指南

提 纲



基层高血压管理办公室

- 基层高血压管理要求
- 高血压诊断
- 高血压治疗
- 高血压与中医药
- 转诊
- 长期随访



基层高血压管理基本要求

- 组建高血压管理团队
 - 由医生、护士、公共卫生人员等组成，鼓励上级医院专科医生加入团队
 - 基层医疗卫生机构负责人领导下，通过签约服务实现
 - 医生应为经国家统一培训合格的医务人员
 - 结合团队服务绩效，建立并完善相应的激励机制



基层高血压管理基本要求

■ 配置基本设备

- 血压计：
 - 推荐使用经认证的上臂式**医用**电子血压计
 - **不建议使用台式水银柱血压计**
 - 不推荐使用腕式或手指式电子血压计
- 检测设备（应配备）：身高体重计、测量腰围的软尺、血常规分析仪、尿常规分析仪、血生化分析仪、心电图机
- 检测设备（可配备）：动态血压监测仪、心脏超声、血管彩色多普勒超声波、胸部X线检查及眼底检查



基层高血压管理要求

- 保障基本药物：应配备下述五大类降压药物
 - A：ACEI和ARB两类药物建议都具备，ACEI与ARB机制类似，无条件的基层医疗卫生机构应至少具备一种
 - B： β 受体阻滞剂类
 - C：CCB，即钙通道阻滞剂，常用于降压的是二氢吡啶类钙通道阻滞剂
 - D：利尿剂，常用于降压的是噻嗪类利尿剂

高血压诊断

- 血压测量
- 诊断标准
- 评估



- 诊室血压是基层医疗机构诊断高血压的主要方式，家庭血压监测和动态血压监测可辅助诊断
- 强调规范测量三要点：**设备精准，安静放松，位置规范**
- 明确血压测量要求及记录方式

诊室血压的规范测量



基层高血压管理办公室

■ 设备精准

• 仪器选择

- 推荐使用经**国际标准认证合格**的上臂式医用电子血压计

• 袖带

- 大小适合患者上臂臂围，袖带气囊至少覆盖80%上臂周径

注意：若袖带宽幅过窄测得血压偏高，过宽血压偏低

• 定期校准

- 电子血压计至少每年1次



诊室血压的规范测量



基层高血压管理办公室

■ 安静放松

- 测量者
 - 测量前30分钟禁止吸烟、禁止喝茶或咖啡，排空膀胱
 - 安静休息至少5分钟
 - 取坐位，双脚平放于地面
 - 测量时安静放松，不说话
- 测量条件
 - 坐位：适合测量者手臂高度的桌子和有靠背的椅子
 - 卧位：准备测试者肘部能外展45° 的诊疗床
- 环境条件：适当空间、适宜温度、环境安静、无噪音

诊室血压的规范测量



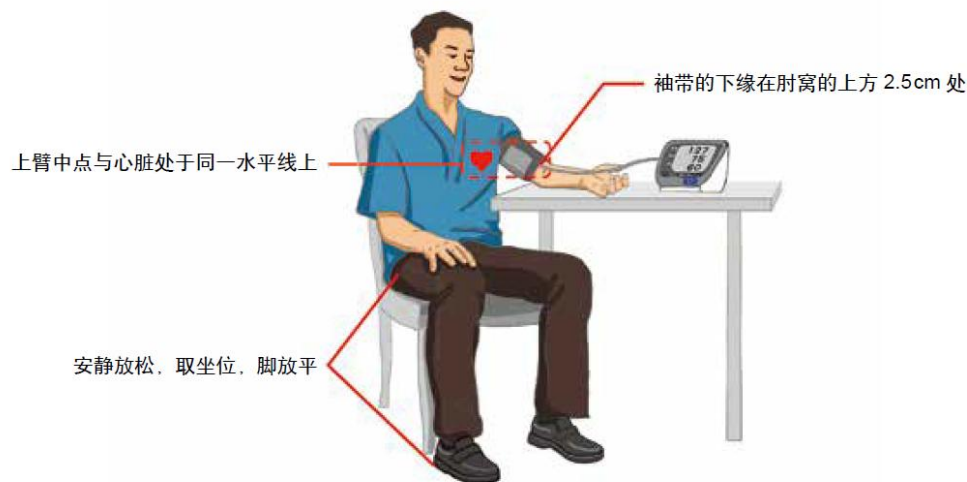
基层高血压管理办公室

■ 位置规范

● 袖带

- 上臂中点与心脏（乳头水平）在同一水平线上
- 袖带下缘：肘窝上2.5cm（约两横指）
- 袖带松紧度：可插入1-2指

注：袖带太紧，收缩压及舒张压均偏低；太松则偏高





诊室血压的规范测量

- 注意：
 - 首诊测量双上臂血压，以后通常测量读数较高的一侧。若双侧测量值差异超过20mmHg，应转诊除外锁骨下动脉狭窄的可能。
 - 每次门诊测量两次，间隔1~2分钟，取两次的平均值记录。如果两次差异 $>10\text{mmHg}$ ，则测量第3次，取后两次的平均值记录。



- 诊室血压：主要诊断依据
 - 诊断标准：非同日3次收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
建议在4周内完成非同日3次测量
 - 诊室首次收缩压 $\geq 180\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $\geq 110\text{ mmHg}$
 - 伴有急性症状者建议立即转诊
 - 无明显症状者，排除其他可能的诱因，并安静休息后复测仍达此标准，即可确诊，建议根据需要给予药物治疗

高血压诊断标准



基层高血压管理办公室

- 诊断不确定，或怀疑“白大衣高血压”或“隐蔽性高血压”
 - 有条件的可结合动态血压监测或家庭血压监测辅助诊断
 - 无条件的，建议转诊
- 紧急或危重情况，以及怀疑继发性高血压，则建议转诊治疗

- 目的：评估心血管病发病风险、靶器官损害及并存的临床情况，是确定高血压治疗策略的基础
- 频次：初诊，及以后每年一次
- 评估内容：
 - 病史：现病史、既往史、用药史等
 - 体格检查：血压、心率（每次），身高、体重、腰围（年度）
 - 辅助检查（建议）：血、尿常规、生化（肝肾功、电解质、血糖、血脂）、心电图

高血压治疗

- 治疗原则
- 降压目标
- 生活方式干预
- 启动药物治疗时机

高血压治疗原则



基层高血压管理办公室

■ 达标

- 降压达标为根本，考虑当地条件及患者承受能力

■ 平稳

- 优选长效药物，平稳降压
- 长期管理：强调长期治疗依从性

■ 综合管理

- 选择降压药时综合考虑伴随疾病
- 其他综合治疗措施：抗血小板及降脂治疗

降压目标



基层高血压管理办公室

- 一般高血压患者血压降至140/90mmHg以下；
- 合并糖尿病、冠心病、心力衰竭、慢性肾脏疾病伴有蛋白尿的患者，如能耐受，血压应降至130/80mmHg以下；
- 65~79岁患者血压降至150/90mmHg以下，如能耐受，可进一步降至140/90mmHg以下；
- 80岁及以上患者血压降至150/90mmHg以下。



所有确诊高血压的患者：
应立即启动并长期坚持生活方式干预

健康生活方式六部曲：
限盐、减重、多运动，戒烟、戒酒、心态平

生活方式干预内容及目标



基层高血压管理办公室

内 容	目 标	收缩压下降范围
减少钠盐摄入	每人每日食盐摄入量不超过6克（一啤酒瓶盖） 注意隐性盐的摄入（咸菜、鸡精、酱油等）	2-8mmHg
减轻体重	BMI<24kg/m ² ,腰围<90cm(男), <85cm(女)	5-20mmHg/ 减重10kg
规律运动	中等强度运动，每次30分钟，每周5-7次	4-9mmHg
戒烟	建议戒烟，避免被动吸烟	/
戒酒	推荐不饮酒，目前在饮酒的高血压患者，建议戒酒	/
心理平衡	减轻精神压力，保持心情愉悦	/

启动药物治疗时机



基层高血压管理办公室

- 所有高血压患者一旦诊断，**建议在生活方式干预的同时立即启动药物治疗**
- 仅收缩压 $<160\text{mmHg}$ 且舒张压 $<100\text{mmHg}$ 且未合并冠心病、心力衰竭、脑卒中、外周动脉粥样硬化病、肾脏疾病或糖尿病的高血压患者，医生也可根据病情及患者意愿暂缓给药，采用单纯生活方式干预最多3个月，若仍未达标，再启动药物治疗

高血压与中医药



■ 辨证论治

- 风阳上亢证：天麻钩藤饮
- 肝肾阴虚证：杞菊地黄丸

■ 中医特色技术

- 针灸、推拿、耳穴贴压、穴位贴敷、刮痧、中药足浴、中药代茶饮、体质调摄

■ 传统运动方式

- 太极拳、八段锦

■ 中医综合调理

高血压转诊

- 初诊转诊
- 随访转诊
- 急救车转诊



- 需向上转诊的人群包括：
 - 起病急
 - 症状重
 - 疑继发
 - 难控制
 - 孕产妇

- 经治疗稳定的原发性高血压患者，上级医院应及时将有关治疗信息推送至对应的基层医疗卫生机构，以便及时跟踪随访

初诊转诊建议



基层高血压管理办公室

- 血压显著升高 $\geq 180/110\text{mmHg}$ ，经短期处理仍无法控制；
- 怀疑新出现心脑血管肾并发症或其他严重临床情况
- 妊娠和哺乳期女性
- 发病年龄 < 30 岁
- 伴蛋白尿或血尿
- 非利尿剂或小剂量利尿剂引起的低血钾
- 阵发性血压升高，伴头痛、心慌、多汗
- 双上肢收缩压差异 $> 20\text{mmHg}$
- 因诊断需要到上级医院进一步检查



随访转诊建议

- 至少三种降压药物（包括一种利尿剂）足量使用，血压仍未达标
- 血压明显波动并难以控制
- 怀疑与降压药物相关且难以处理的不良反应
- 随访过程中发现严重临床疾患或心脑血管肾损害而难以处理

急救车转诊建议



基层高血压管理办公室

- 意识丧失或模糊
- 血压 $\geq 180/110\text{mmHg}$ 伴剧烈头痛、呕吐，或突发言语障碍和/或肢体瘫痪（怀疑急性脑卒中）
- 血压显著升高伴持续性胸背部剧烈疼痛（怀疑夹层动脉瘤）
- 血压升高伴下肢水肿、呼吸困难，或不能平卧（怀疑急性左心衰）
- 胸闷、胸痛持续至少10分钟，伴大汗，心电图见至少两个导联ST段抬高（怀疑ST段抬高型心肌梗死）
- 其他影响生命体征的严重情况，如意识淡漠伴血压过低或测不出、心率过慢或过快，突发全身性严重过敏反应等

高血压长期随访管理

随访频率及内容



基层高血压管理办公室

■ 随访频率

- 血压达标患者：至少每3个月随访1次
- 血压未达标患者：2~4周随访1次
- 符合转诊条件的建议按照转诊要求操作

■ 随访内容

- 随访时应询问上次随访至今是否有新诊断的合并症，如冠心病、心力衰竭、心房颤动、脑卒中、糖尿病、慢性肾脏疾病或外周动脉粥样硬化病等
- 每次随访均应查体（检查血压、心率等，超重或肥胖者应监测体重及腰围）
- 生活方式评估及建议
- 了解服药依从性及不良反应情况，必要时调整治疗



■ 年度评估

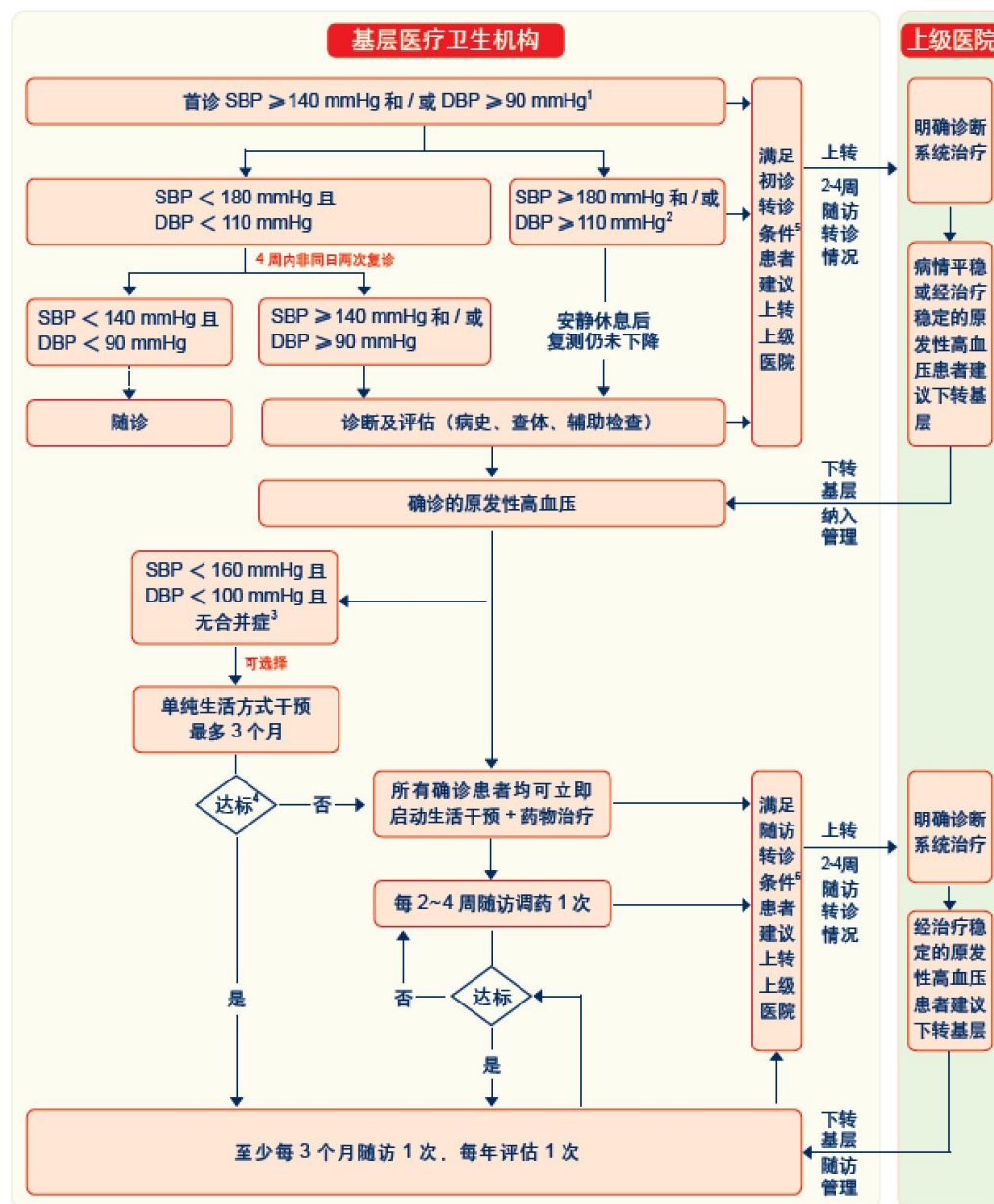
- 频率：每年1次，可随每3个月随访完成
- 内容：除常规每3个月随访内容外，每年复查体重、腰围，并建议进行必要的辅助检查（同初诊评估），即血常规、尿常规、生化（肌酐、尿酸、谷丙转氨酶、电解质、血糖、血脂）、心电图
- 有条件者可选做：动态血压监测、超声心动图、颈动脉超声、尿白蛋白/肌酐、胸片、眼底检查等

所有患者均应进行年度评估

基层高血压管理流程



基层高血压管理办公室





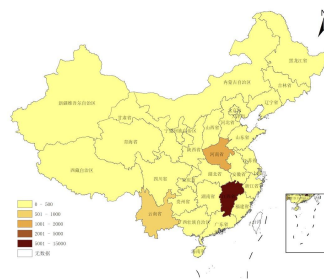
基层高血压诊疗关键点

- **血压测量“三要点”**：设备精准，安静放松，位置规范
- **诊断要点**：诊室血压为主，140/90mmHg为界，非同日三次超标确诊
- **健康生活方式“六部曲”**：限盐减重多运动，戒烟戒酒心态平
- **治疗“三原则”**：达标、平稳、综合管理
- **基层高血压转诊五类人群**：起病急、症状重、疑继发、难控制、孕产妇

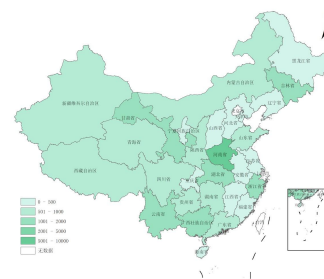
《指南》推广培训（高低并重、点面结合）

“雄鹰计划” 骨干培训班（点、高）

- 对象：基层高血压管理骨干人员
- 形式：集中培训，三天
- 进展：已举办 48 期，累计培训骨干 2 万名



“雄鹰计划” 培训学员分布



“群雁计划” 培训学员分布

“群雁计划” 区域培训会（面、低）

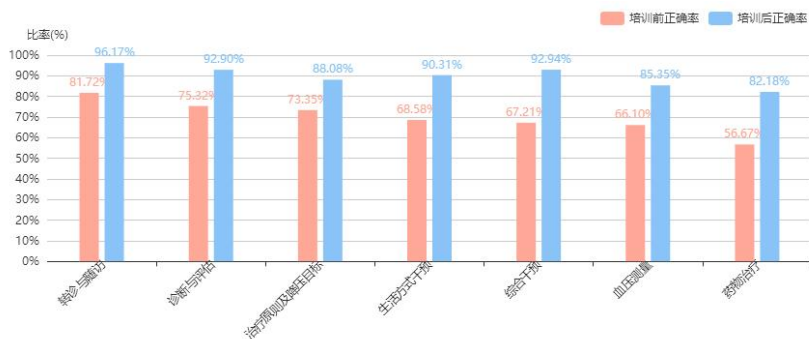
- 对象：基层医务人员（含乡村医生）
- 形式：县域培训，一天
- 进展：已举办 246 场，累计培训基层医生 4 万余名



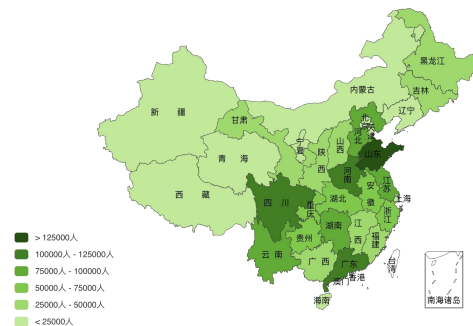
“云鹊计划” 线上培训

2018年起快速覆盖全国

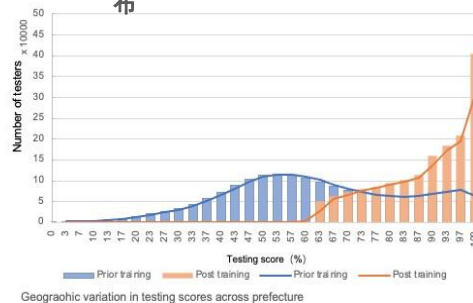
- 覆盖31省，349市，42万基层医疗卫生机构
- 基本实现全国地级市全覆盖，基层医疗机构覆盖比例42%
- 培训235余万人，获证200万人（含140万基层医生），平均成绩从培训前的71分升至培训后的88分



培训前后比较：定位内容难点，精准培训



“云鹊计划” 培训学员分布



培训前后比较：成绩显著提升，地区间差异缩小

设计制作多种形式科普材料

科普书籍

- 书籍1《用心守护-心血管病防治漫谈画》
- 书籍2《高血压防治必备知识-入门篇》

科普影音

- 动画视频：30个
- 沙画视频：10个
- 基层防控纪录片：5个

科普海报

- 数量：11幅

科普图文

- 数量：40篇



科普材料免费下载地址：hpb-office.nccd.org.cn

打造基层高血压科普阵地



科普公众
号



科普抖音
号

公众号科普宣教平台

- 推送 **1300余篇**科普知识图文
- 观看次数 **506万人次**

短视频科普宣教平台

- 发布科普视频 200余支
- 观看次数 **947 万人次**

办公室官网科普宣教专区

- 观看次数 **420 万人次**
- 科普宣教资料下载 **51 万人次**



中国循环杂志



国家心血管中心



中国医学科学院阜外医院



央视网



阜外说心脏

新媒体宣教矩阵



国家基本公共卫生服务项目



快手



搜狐新闻



微博



抖音



基层高血压管理办公室



百度



头条



1. 一点资讯



大风号

开展多种形式健康教育活动

高血压教育讲堂-系列直播

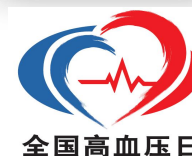
- 累计开展 **50期**
- 累计观看人数 **654万人**

科普材料实物推广

- 累计印制各类科普材料近 **60万册/个**
- 下发范围覆盖 **31省市**

现场义诊、大讲堂

- 持续开展义诊 **8场**，累计义诊 **1000余人**
- 世界高血压日、全国高血压日



谢谢！